

	Mapa de Processos: Serviço de Imagem e Endoscopia	Código: tag_ds_codigo_end
	Dono do Processo: Coordenador(a) do Serviço de Imagem e Endoscopia	Versão: tag_ds-versao_end
	Início do Processo: Solicitação de exame médico via sistema MV	
	Fim do Processo: Entrega de laudo/imagens (digitais ou impressas) ao paciente e à equipe assistencial, com atualização dos registros no sistema.	

FORNECEDORES	ENTRADA	PRINCIPAIS ATIVIDADES	PRODUTOS	CLIENTES
Médicos	Solicitação de exames via sistema MV.	1) Recebimento e Organização de Pedidos de Exames 2) Priorização e Agendamento de Exames 3) Comunicação e Transporte do Paciente 4) Realização do Exame de Imagem 5) Emissão e Validação de Laudos Médicos 6) Gestão de Materiais 7) Controle de Qualidade dos Documentos	Agenda de exame, Laudos médicos e resultados dos exames	Pacientes, Setores Assistenciais e de Internação
Setores assistenciais e de internação	Pacientes preparados (jejum, acesso, ISBAR).		Exames agendados com terceiros (RM, Eletroencefalograma)	Empresas terceiras
TI	Sistema Operacional.		Solicitação de material	farmácia e almoxarifado
Farmácia	Material médico hospitalar.		Solicitação de Ordem de Serviço	TI Engenharia Clínica
Almoxarifado	Material médico hospitalar e administrativo.		Programação anual de materiais, Requisições diárias via sistema MV	Almoxarifado
Paciente (PBH e ambulatório)	Encaminhamento para realização de exame.			Transporte
Engenharia Clínica	Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.			

Empresas terceirizadas	Laudos remotos; Controle de qualidade dos equipamentos da radiologia; Realização de exames de RM, Tomografia e Eletroneuromiografia.		
Transporte	Informação de cancelamento ou não realização do exame pela empresa terceirizada.		Quinta tarde

DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES

1) **Recebimento e Organização de Pedidos de Exames:** Após o médico solicitar o exame no sistema MV, o sistema gera automaticamente um PDF da solicitação para impressão na recepção do setor de imagem e endoscopia. A auxiliar administrativa organiza os pedidos manualmente por tipo de exame (tomografia, RX, ultrassom, eco, endoscopia, duplex), garantindo rastreabilidade e a priorização é organizada pelo médico executante.

2) **Priorização e Agendamento de Exames:** Com os pedidos de exames organizados e separados, é realizada uma avaliação médica das solicitações para definir prioridade (urgente e a serem agendados). Os exames a serem agendados são agendados pela auxiliar administrativo via sistema MV.

Para exames ambulatoriais:

- O paciente que teve alta hospitalar e tem encaminhamento de exame de imagem realiza o agendamento pessoalmente no setor SIE ou por contato telefônico;
- O paciente atendido via ambulatório com solicitação de exame para RX será direcionado para o setor e realizará o exame.
- O paciente encaminhado pela PBH para realização de RX tem o agendamento realizado via SISREG.

Para os exames de pacientes internados ou em atendimento de ficha serão realizados por ordem de chegada ou prioridade.

3) **Comunicação e Transporte do Paciente:** O Setor entra em contato com as equipes assistenciais informando o agendamento do exame, e pré-requisitos para realizá-lo. As equipes de enfermagem dos setores de origem são responsáveis por preparar o paciente (jejum, acesso venoso calibroso, preenchimento do ISBAR de transporte, em caso de procedimentos invasivos o TCLE) e encaminhá-lo até o setor de imagem. O transporte pode ser feito por técnicos de enfermagem ou, em casos críticos, com apoio do setor de imagem e endoscopia.

4) **Realização do Exame de Imagem:** Para os pacientes que preenchem todos os requisitos para a realização do exame solicitado (ex: jejum e acesso venoso), é realizado por técnicos em radiologia/enfermagem a execução técnica do exame solicitado, que são divididos em dois grupos: Exames de Imagem (Tomografia Computadorizada (TC), Raio-X (RX), Ultrassonografia (US), Ecocardiograma (ECO), Duplex Scan (US com doppler)); Exames Endoscópicos (Endoscopia Digestiva Alta, Colonoscopia, Gastrostomia e CPRE). São aplicados protocolos de posicionamento, administração de contraste, utilização de equipamentos móveis ou fixos e verificação da qualidade da imagem antes da liberação. Caso necessário, o paciente pode ser enviado para fora para realizar exames via terceiros que não são feitos

no HRTN (Ressonância Magnética (RM), Eletroencefalografia). Após a realização do exame, o paciente retorna ao setor de origem com apoio da equipe de enfermagem. O status do exame é atualizado no sistema MV. Para os casos de pacientes que não realizaram o procedimento por algum motivo (ISBAAR, preparo) o mesmo será reagendado.

- 5) **Emissão e Validação de Laudos Médicos:** Ao final do exame, as imagens passam por análise de médicos radiologistas ou especialistas, com emissão de laudo digital no sistema MV/PACS. Laudos de urgência devem ser liberados em até 2 horas (via telerradiologia/VX) e os demais em até 12 horas. As imagens/laudos são disponibilizados digitalmente no sistema.
- 6) **Gestão de Materiais:** A gestão dos medicamentos no setor é realizada conforme a prescrição médica. É de responsabilidade da equipe de enfermagem organizar, conferir e auditar o estoque conforme a prescrição citada acima. Os insumos são solicitados pela própria equipe assistencial visando manter o estoque mínimo para garantir o atendimento. Materiais de escritório são solicitados pelo auxiliar administrativo.

PRINCIPAIS PROBLEMAS

- **Falta de comunicação entre setores:** Há dificuldade no contato com a enfermagem e outros setores, o que causa atrasos e retrabalho.
- **Pedidos duplicados:** Médicos realizam solicitações repetidas, mesmo com alerta no sistema MV, comprometendo o fluxo e expondo o paciente.
- **Demora no transporte de pacientes:** O tempo de espera para que o paciente chegue ao setor pode ultrapassar duas horas, impactando o uso dos equipamentos.
- **Ausência de equipe de transporte dedicada:** O transporte depende de setores assistenciais, sobrecarregando técnicos e gerando atrasos.
- **Preparo inadequado do paciente:** Pacientes chegam sem jejum, sem acesso venoso ou com SBAR incompleto, o que causa cancelamentos e retrabalho.
- **Falta de médicos em horários críticos:** Ausência de médicos para ECO nos fins de semana e de anestesistas para colonoscopia reduz a capacidade de atendimento.
- **Uso excessivo de papel:** Muitos documentos ainda são impressos (pedidos, imagens, laudos).
- **Fragilidade na entrega de documentos:** Pacientes retornam ao hospital por não terem recebido/acessado laudos ou imagens.
- **Equipamentos desatualizados:** Alguns aparelhos não integram com o sistema PACS, obrigando a impressão das imagens.
- **Dependência de serviços terceirizados:** Exames como RM e Eletroencefalografia dependem de agendamento externo, ampliando o tempo de permanência do paciente.
- **Máquina ociosa por falta de preparo:** Equipamentos ficam parados enquanto a equipe tenta resolver pendências do paciente.
- **Sobrecarga da equipe técnica:** Técnicos acumulam funções de agendamento, transporte e execução dos exames.

INDICADORES DE DESEMPENHO DO PROCESSO	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA PARA O PROCESSO
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)	1) 1-4 2) 1,5,7 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Grau de Padronização do Processo				
Durante a execução deste processo, seguimos um ciclo de etapas/atividades bem regulado/estabelecido.				
() Concordo plenamente	() Concordo	() Concordo parcialmente	() Discordo	() Discordo totalmente
Este processo é organizado de forma eficiente.				

() Concordo plenamente	() Concordo	() Concordo parcialmente	() Discordo	() Discordo totalmente
A execução deste processo é altamente padronizada.				
() Concordo plenamente	() Concordo	() Concordo parcialmente	() Discordo	() Discordo totalmente
Em grande parte, documentamos todas as ações realizadas neste processo.				
() Concordo plenamente	() Concordo	() Concordo parcialmente	() Discordo	() Discordo totalmente